Provão Urologia e Nefrologia. 27 de Junho de 2019

1) Sobre a Doença Renal Policística:
   a. Mutação no gene PKD2 é mais frequente que em PKD1
   b. O alvo da osmolalidade urinária é de 100 mOsm/KgH2O para diminuir o crescimento dos cistos
   c. A tipo 1 é mais benigna que a tipo 2
   d. As células dos cistos apresentam mutação nós dois alelos dos genes PKD

2) Exemplos de IRA Pré-Renal:
   a. Rabdomiólise, vômitos e diarreia
   b. Trombose de veia renal, infarto agudo do miocárdio e vômitos
   c. Hiperplasia prostática benigna, infarto agudo do miocárdio e diarreia
   d. Insuficiência cardíaca, diarreia e vômitos

3) Bactéria mais frequente na Infecção do Trato Urinário:
   a. E. coli
   b. Proteus mirabilis
   c. Klebsiella sp
   d. Pseudomona sp

4) Na verdadeira hematúria glomerular o teste de dismorfismo eritrocitário mostra alterações de forma utilizando:
   a. Microscópio de imunofluorescência
   b. Microscópio óptico
   c. Microscópio eletrônico
   d. Microscópio de contraste de fase

5) Causa mais frequente de litíase urinária:
   a. Estruvita
   b. Oxalato de fósforo
   c. Oxalato de cálcio
   d. Ácido úrico

6) Qual antibiótico que tem menor resistência bacteriana na ITU?
   a) Sulfametoxazol + Trimetoprima
   b) Amoxicilina
   c) Nitrofurantoína
   d) Ciprofloxacino

7)Classificação G3bA2 ta TFG e microalbuminúria corresponde a
   a) TFG 30-49; albumina 30-300
   b) TFG 70-90; albumina <30
   c) TFG 15-30; albumina >300
   d) TFG 30-44/ albumina 30-300

8)Porque a maior causa de DRC no brasil é Hipertensão, e nos países desenvolvidos é a Diabetes?

a) Resposta no gabarito

9)

10)

11)

12) A classificação KDOQI da Lesão renal aguda foi estabelecida para:
a) Homogeneizar os critérios diagnósticos de LRA
b) Escalonar o risco de mortalidade da LRA
c) Auxiliar nos critérios de indicação de terapia de substituição da função renal
d) Todos os itens acima

13)Paciente de 65 anos, sexo feminino, com antecedente de Câncer de estômago há 02 anos, evoluiu com síndrome nefrótica. A biópsia renal da paciente mostra espessamento da membrana basal glomerular sem proliferação capsular ou presença de crescentes. O diagnóstico baseado nas informações é:
a) Glomerulonefrite por lesão mínima
b) Glomeruloesclerose segmentar e focal
c) Membranosa
d) Membranoproliferativa

14) Paciente de 6 anos, sexo feminino, com presença de edema há 02 dias, cansaço, dispneia, com urina escura e avermelhada. Refere ter tido histórico de amigdalite purulenta há 3 meses atrás. Por essas informações, qual o diagnóstico mais provável e sua respectiva conduta:
a) Glomerulonefrite pós estreptocócica, uso de diuréticos
b) Nefrite lúpica, uso de corticóides
c) Glomerulonefrite rapidamente progressiva, uso de IECA
d) Vasculite renal, uso de imunossupressor

15)

16)

17)

18) Qual a principal causa metabólica de litíase urinária

a) Hipercalciúria primária
b) Hiperoxalúria
c) Cistinúria
d) Hipomagnesúria

19) Qual afirmação está incorreta sobre os fármacos Sildenafil, Tadalafil e Vardenafil

a) Comida gordurosa inibe a absorção de Sildenafil e Vardenafil, mas não de Tadalafila
b) O prejuízo visual é mais comum na Sildenafil do que na Vardenafil e Tadalafil
c) A maior meia vida plasmática é de Tadalafil
d) Mialgia e dor lombar é menos comum na Tadalafil

20) Qual afirmação está incorreta sobre os fármacos Finasterida e Dutasterida

a) Finasterida diminui menos a DHT plasmática que Dutasterida
b) Finasterida diminui de 20 a 30% o volume da próstata enquanto Dutasterida diminui 26%
c) Disfunção erétil é igualmente comum na FInasterida e na Dutasterida e é aproximadamente de 8%
d) Diminuição do libido é 3 vezes mais maior na Finasterida que na Dutasterida

21) Marque a alternativa incorreta em relação aos antagonistas alfa-1 utilizados no tratamento da HPB:

a) Os novos antagonistas alfa-1, como a tansulosina e a alfuzosina provocam menos hipotensão e podem ser administradas uma vez ao dia.
b) A tansulosina tem sido o mais utilizado atualmente.
c) Existe a possibilidade de tratamento combinado da HPB: tansulosina + finasterida.
d) A terazosina, por ser um antagonista alfa-1-C, é o fármaco mais potente para o tratamento da HPB.

22) Sobre escroto agudo, assinale a correta:

a) Ultrassonografia com doppler é exame que nada ajuda na investigação.
b) Torção do cordão espermático (ou de testículo) é o diagnóstico a ser excluído no atendimento do paciente com dor testicular aguda. Sabe-se que quase a totalidade dos testículos é preservada quando a exploração cirúrgica é realizada em até 6h do início do quadro.
c) Em caso de abordagem cirúrgica em que confirme a torção testicular, a fixação do testículo contralateral não é necessária.
d) Traumas contusos de testículo não podem ter indicação de tratamento cirúrgico.

23) Hidronefrose antenatal é um achado comum em ultrassonografias obstétricas. Acerca dessas alterações responda a correta:

a) VUP é causa de hidronefrose antenatal. Não pode cursar com IRC.
b) RVU - nem todos os casos são cirúrgicos. Tratamento visa impedir ITU febril.
c) JUP é a mais frequente. Nunca é cirúrgico.
d) Terapias endoscópicas não podem ser usadas para tratamento de RVU.

24) Sobre hipospádia:

a) A grande maioria é anterior ou distal (até 50% dos casos).
b) Hipospádias posteriores (penoescrotal, escrotal ou perineal) são de correção mais simples que as distais.
c) Há apenas uma técnica cirúrgica para correção de hipospádia.
d) Hipospádias posteriores não tem relação com infertilidade.

25) A dosagem de antígeno prostático específico (PSA) tem aumentado sua importância na prática médica. Sobre o PSA:

a) Não se altera com infecção urinária.
b) PSA na hiperplasia prostática benigna aumenta 0.8 ng/g de tecido hiperplásico por ano; enquanto no câncer de próstata aumenta cerca de 3 vezes mais.
c) Relação PSA livre/total > 20% é sugestiva de malignidade.
d) Uso de inibidor da 5 alfa-redutase diminui em 50 % o valor do PSA após 1 ano de tratamento.

26) Acerca da Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) assinale a correta: ?

a) Paciente com sintomas de esvaziamento e próstata maior que 40 gramas é indicação de tratamento cirúrgico.
b) Uretrocistografia retrógrada e miccional faz diagnóstico de obstrução prostática.
c) Paciente castrado antes da puberdade não desenvolve HPB.
d) Fluxo urinário > 150 ml indica descompensação detrusora.

27)

28)

29)

30) Reconstrução urinária pós cistectomia radical

a) Qualquer paciente pode ser candidato a neobexiga ao invés de derivações externas
b) Distúrbios hidroeletrolíticos são pouco frequentes no P.O.
c) Neobexiga tem mesmo padrão de contração e esvaziamento
d) Preserva porção distal do íleo devido absorção de B12

31)Indicações absolutas de intervenção cirúrgica no trauma renal

a) Hematoma retroperitoneal pulsátil ou em expansão
b) Lesão de alto grau
c) Extravasamento de contraste
d) Estadiamento incompleto

32) Bactérias comuns em ITU

a) Pseudomonas e Staphilo em gestantes
b) Staphylo saprophticus cresce rápido e diagnóstico é fácil
c) S. aureus dissemina hematogênico
d) E beta hemolítico grupo B é comum nosocomial

33) São fatores predisponentes para ITU

A. Incontinência urinária na infância
B. Alteração hormonal em mulheres jovens
C. Início precoce da vida sexual em homens.
D. Uso recente de antibióticos

34) Qual a zona mais afetada no câncer de próstata?
A. Zona central
B. Zona anterior
C. Zona periférica
D. Zona de transição.

35) Paciente com adenocarcinoma de próstata, estádio T3bN0M0. O tumor é:
A. palpável no toque retal, invade vesícula seminal, sem metástase ganglionar ou a distância.
B. impalpável no toque retal, invade um lado da próstata, com metástase ganglionar ou a distância
C. impalpável no toque retal, invade músculo elevador do ânus, sem metástase ganglionar ou a distância.
D. palpável no toque retal, invade os dois lados da próstata, com metástase ganglionar ou a distância.

36)

37)

38)

39) Paciente 26 anos de idade, feminino, apresentando febre, dor na região lombar e disúria. EAS - (medlab?)
Nitrito +
Aspecto turvo
Cor amarelo escuro
Proteína = 300
Hemácias = +++/4+
Leucocitos = 145.000
Hemácias = 500.000
    Isomorficas = 200.000
    Dismórficas = 400.000
Células tubulares = 80.000

40) Paciente, sexo masculino, 19 anos, vida sexual ativa (várias parceiras nos últimos meses). Notou aparecimento de lesão papular, cinco dias após relação sexual com desconhecida, sendo que esta lesão ulcerou, apresentou bases irregulares, não endurecidas, extremamente dolorosas, e apareceram em pele de região próxima também (“lesões em beijo”) e depois passou a apresentar adenopatia inguinal, unilateral, que passou a drenar secreção purulenta, por único ponto de secreção purulenta. Para confirmar sua hipótese clínica, dentre os exames abaixo, qual seria o mais indicado?

A) Pesquisa de corpúsculo de donovan (em secreção corada pelo Leishman ou biópsia corada pelo Giemsa)
B) Pesquisa de bacilos gram negativos através de bacterioscopia pelo gram da secreção drenada do bulbão.
C) Pesquisa de Clamidia na secreção do bulbão, através, por exemplo, de IFD ou por PCR para clamidia.
D) Bacterioscopia pelo gram da secreção do bulbão, com ênfase a pesquisa de diplococos gram negativos, intra e extracelulares.

GABARITO

1. D
2. D
3. A
4. D
5. C
6. C
7. TFG 30-44/ albumina 30-300
8. Baixa adesão ao tratamento
9. -
10. -
11. -
12. D
13. C
14. A
15. -
16. -
17. -
18. A
19. D
20. D
21. D
22. B
23. B
24. A
25. D
26. D
27. -
28. -
29. -
30. D
31. A

32. C
33. D
34. C
35. A
36. -
37. -
38. -
39. ITU alta
40. B

GABARITO COMENTADO | UROLOGIA E NEFROLOGIA

Prova de 27 de junho de 2019 | Anexo às 7 páginas originais

Critério: revisão crítica das respostas já destacadas na prova, com checagem de diretrizes e literatura médica. As respostas são propostas técnicas independentes do gabarito inserido no arquivo de 2019. Em perguntas incorretas ou incompletas, há registro expresso dessa limitação.

Escopo: 28 itens com texto aproveitável (26 de múltipla escolha e 2 sem alternativas); 12 numerações não contêm enunciado suficiente. O apêndice traz análise das 104 alternativas existentes, duas questões discursivas/incompletas e referências verificáveis.

Gabarito resumido (revisado)

01 D	**06 C***
02 D	**07 D**
03 A	**08 SEM LETRA**
04 D	**09 —**
05 C	**10 —**

11 —	**16 —**
12 A*	**17 —**
13 C	**18 A**
14 A*	**19 D**
15 —	**20 D***

21 D	**26 C***
22 B	**27 —**
23 B	**28 —**
24 SEM VÁLIDA	**29 —**
25 D	**30 D**

31 A	**36 —**
32 C	**37 —**
33 D*	**38 —**
34 C	**39 SEM LETRA**
35 A	**40 B***

Legenda: “*” indica ressalva técnica; “SEM VÁLIDA” significa que nenhuma alternativa é rigorosamente correta; “SEM LETRA” indica questão discursiva ou sem opções; “—” indica numeração sem enunciado suficiente.

Numerações sem texto aproveitável: 9, 10, 11, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 36, 37, 38. Não foram reconstruídas nem respondidas por suposição.

Questões que exigem cautela

08: explicação epidemiológica original insuficiente; 12: classificação não determina, isoladamente, diálise; 14: latência pós-faringite atípica; 20: taxas percentuais não universais; 24: alternativa A contradiz a própria expressão “maioria”; 26: resposta C substitui D do gabarito antigo; 33: possível ambiguidade; 39: contagens incongruentes; 40: método laboratorial proposto é insuficiente para confirmar cancro mole.

Comentários de todas as questões disponíveis

QUESTÃO 1 | Doença renal policística autossômica dominante (DRPAD) | D

A - INCORRETA. PKD1 é mais frequente que PKD2 na DRPAD, embora as proporções variem segundo a população estudada.

B - INCORRETA. Não existe recomendação universal de osmolalidade urinária de 100 mOsm/kg. Hidratação, vasopressina e metas individualizadas dependem de função renal, sintomas e risco.

C - INCORRETA. Em geral, doença por PKD1 evolui com fenótipo renal mais grave e perda de função mais precoce que PKD2.

D - CORRETA NO MODELO CLÁSSICO. A formação focal de cistos pode seguir o modelo de dois eventos (two-hit), com variante germinativa em uma cópia e inativação somática da cópia funcional no epitélio cístico.

Ressalva / interpretação: “Dois alelos” não significa que PKD1 e PKD2 precisem ambos estar alterados. O modelo de dois eventos explica muitos cistos, sem impor que todos tenham mecanismo idêntico.

Fontes: [1], [2].

QUESTÃO 2 | Causas de injúria renal aguda (IRA) pré-renal | D

A - INCORRETA. Vômitos e diarreia geram hipovolemia pré-renal, mas rabdomiólise é causa típica de lesão tubular intrínseca por mioglobina.

B - INCORRETA. IAM pode reduzir perfusão renal e vômitos causam depleção volêmica, mas trombose de veia renal representa doença vascular renal, não exemplo habitual de IRA pré-renal.

C - INCORRETA. Hiperplasia prostática benigna com retenção constitui causa pós-renal; IAM e diarreia podem desencadear componente pré-renal.

D - CORRETA. Insuficiência cardíaca, diarreia e vômitos podem comprometer a perfusão renal, por baixo débito ou perda de volume circulante efetivo.

Fontes: [3].

QUESTÃO 3 | Agente mais frequente de infecção do trato urinário | A

A - CORRETA. Escherichia coli é o principal uropatógeno nas ITUs comunitárias, especialmente nas cistites não complicadas.

B - INCORRETA. Proteus mirabilis causa ITU e pode formar cálculos de estruvita, mas é menos comum que E. coli.

C - INCORRETA. Klebsiella spp. é agente relevante, sobretudo em pacientes com comorbidades ou assistência à saúde, mas não o predominante globalmente.

D - INCORRETA. Pseudomonas spp. relaciona-se a ITU complicada, cateterização e ambiente hospitalar; não lidera a frequência geral.

Fontes: [4], [30].

QUESTÃO 4 | Dismorfismo eritrocitário na hematúria glomerular | D

A - INCORRETA. Imunofluorescência é usada para identificar marcadores ou depósitos, principalmente em biópsias, não para a avaliação morfológica habitual dos eritrócitos urinários.

B - INSUFICIENTE COMO RESPOSTA CLÁSSICA. A microscopia óptica comum pode mostrar hemácias e alterações, mas oferece menor resolução de detalhes morfológicos nesse uso.

C - INCORRETA. Microscopia eletrônica não é o método rotineiro para contagem e descrição de dismorfismo eritrocitário na urina.

D - CORRETA. Microscopia de contraste de fase permite reconhecer dismorfismo, sobretudo acantócitos, reforçando origem glomerular da hematúria.

Ressalva / interpretação: A presença de hemácias dismórficas é sugestiva, não equivalente a diagnóstico etiológico definitivo. Interpretar junto a cilindros, albuminúria e quadro clínico.

Fontes: [19].

QUESTÃO 5 | Composição mais frequente dos cálculos urinários | C

A - INCORRETA. Estruvita é típica de cálculos relacionados a infecção por bactérias produtoras de urease; representa parcela menor.

B - INCORRETA. “Oxalato de fósforo” não corresponde à classificação composicional usual; fosfato de cálcio e oxalato de cálcio são categorias distintas.

C - CORRETA. Os cálculos de oxalato de cálcio são os mais frequentes na população geral.

D - INCORRETA. Cálculos de ácido úrico são relevantes, sobretudo com urina ácida, mas não os mais comuns.

Fontes: [21].

QUESTÃO 6 | Antibiótico com menor resistência na ITU | C*

A - MENOS ADEQUADA EMPIRICAMENTE. A resistência de E. coli a sulfametoxazol-trimetoprima pode ser elevada e deve orientar-se por antibiograma e epidemiologia local.

B - MENOS ADEQUADA. Resistência às aminopenicilinas, como amoxicilina isolada, é frequente em uropatógenos comuns.

C - MELHOR RESPOSTA PROVÁVEL. Nitrofurantoína mantém, em muitos cenários, boa atividade contra E. coli e figura como primeira linha na cistite localizada em mulheres.

D - MENOS ADEQUADA. Resistência às fluoroquinolonas e riscos de efeitos adversos limitam ciprofloxacino como primeira escolha em cistite simples.

Ressalva / interpretação: Não existe antibiótico universalmente “de menor resistência”: depende de espécie, local, ano e população. Nitrofurantoína não é tratamento adequado para pielonefrite por baixa concentração tecidual renal.

Fontes: [4].

QUESTÃO 7 | Classificação G3bA2 da DRC | D

A - INCORRETA. G3b exige TFG 30-44, não 30-49 mL/min/1,73 m².

B - INCORRETA. TFG 70-90 e albuminúria inferior a 30 não correspondem a G3bA2.

C - INCORRETA. TFG 15-29 representa G4; albuminúria superior a 300 mg/g é A3.

D - CORRETA. G3b corresponde a TFG 30-44 mL/min/1,73 m²; A2 corresponde a relação albumina/creatinina urinária 30-300 mg/g (aproximadamente).

Ressalva / interpretação: Para classificar DRC são necessários critérios de cronicidade de pelo menos 3 meses, não apenas uma medida isolada.

Fontes: [31].

QUESTÃO 8 | Causas de DRC no Brasil: questão discursiva | SEM LETRA

Ressalva / interpretação: Questão apresentada sem alternativas e com o pressuposto de que HAS lideraria no Brasil e diabetes nos países desenvolvidos. O gabarito antigo responde “baixa adesão ao tratamento”, mas isso NÃO é explicação causal única demonstrada. Em 2023, o censo de diálise brasileiro atribuía 37% à HAS e 31% ao diabetes; em 2024, as duas causas apareceram empatadas, com 29% cada. Classificações de etiologia, diferenças entre coortes, acesso a cuidado e controle de fatores de risco interferem nos registros. Resposta prudente: a predominância varia por ano e metodologia, sem atribuir o contraste exclusivamente à adesão.

Fontes: [17], [18].

QUESTÃO 12 | Finalidade da classificação de lesão renal aguda | A*

A - CORRETA COMO FINALIDADE PRIMÁRIA. Critérios padronizados permitem uniformizar diagnóstico e gravidade da IRA/LRA e comparar estudos e serviços.

B - VERDADEIRA COMO CONSEQUÊNCIA, não como finalidade isolada: estágios crescentes se associam a risco maior de mortalidade e outros desfechos.

C - IMPRECISA. A estratificação auxilia avaliação de gravidade, mas não determina isoladamente indicação de diálise, que depende de alterações clínicas e metabólicas.

D - NÃO RIGOROSAMENTE CORRETA. “Todas” pressupõe que a classificação estabelece critérios de terapia substitutiva; na prática, ela não substitui a avaliação clínica.

Ressalva / interpretação: O arquivo fala “KDOQI”, embora as classificações usuais de IRA sejam RIFLE, AKIN e KDIGO. O gabarito original marca D; com leitura rigorosa das recomendações atuais, A é mais defensável, reconhecendo-se a utilidade prognóstica de B.

Fontes: [3].

QUESTÃO 13 | Síndrome nefrótica com neoplasia gástrica prévia | C

A - INCORRETA. Doença de lesões mínimas geralmente mostra glomérulos de aspecto quase normal à microscopia óptica.

B - INCORRETA. GESF apresenta esclerose de segmentos de alguns glomérulos, não espessamento difuso isolado da membrana basal.

C - CORRETA. Nefropatia membranosa cursa com espessamento de paredes capilares sem proliferação marcante; pode estar associada a tumores sólidos.

D - INCORRETA. Padrão membranoproliferativo tipicamente envolve proliferação mesangial/endocapilar e duplicação da membrana basal.

Ressalva / interpretação: Histologia descritiva isolada é sugestiva, não confirma mecanismo tumoral. Imunofluorescência, microscopia eletrônica e estudo etiológico são necessários.

Fontes: [32].

QUESTÃO 14 | Síndrome nefrítica após amigdalite: intervalo atípico | A*

A - MELHOR ENTRE AS OFERECIDAS. Glomerulonefrite pós-estreptocócica pode causar edema, hematúria macroscópica, hipertensão e oligúria; diuréticos de alça são usados conforme sobrecarga de volume.

B - MENOS PROVÁVEL. Nefrite lúpica requer contexto clínico-imunológico compatível, não fornecido; corticoides não devem ser presumidos.

C - MENOS PROVÁVEL. Glomerulonefrite rapidamente progressiva demanda evidência de declínio acelerado da função renal e investigação urgente, não apenas IECA.

D - MENOS PROVÁVEL. Vasculite renal exige sinais e exames de suporte; imunossupressão não deve ser instituída apenas pelos sintomas apresentados.

Ressalva / interpretação: RESSALVA RELEVANTE: três meses entre amigdalite e síndrome nefrítica fogem ao período habitual pós-faringite estreptocócica (cerca de 10 dias; geralmente 1-3 semanas). Confirmar função renal, complemento C3, ASO/anti-DNase B, pressão arterial e outras etiologias antes de fechar diagnóstico.

Fontes: [16].

QUESTÃO 18 | Anormalidade metabólica frequente na litíase | A

A - CORRETA ENTRE AS OPÇÕES. Hipercalciúria é uma das alterações metabólicas mais frequentes associadas a cálculos de cálcio; frequentemente é idiopática.

B - INCORRETA COMO PRINCIPAL GERAL. Hiperoxalúria é importante, mas não é o marcador mais clássico entre as opções para litíase cálcica.

C - INCORRETA. Cistinúria é doença hereditária rara que causa cálculos de cistina.

D - INCORRETA. Hipomagnesúria é fator predisponente menos comum do que hipercalciúria.

Ressalva / interpretação: A frequência relativa de hipercalciúria e hiperoxalúria depende de critérios e população; a EAU relata faixas sobrepostas. O termo “primária” no arquivo provavelmente pretende dizer hipercalciúria idiopática.

Fontes: [5].

QUESTÃO 19 | Inibidores de PDE5: sildenafil, tadalafil e vardenafil | D

A - ESSENCIALMENTE CORRETA, COM RESSALVA. Refeição gordurosa pode atrasar a absorção de sildenafil e vardenafil; tadalafil sofre pouca interferência alimentar. “Inibir” é termo impreciso.

B - CORRETA EM TERMOS COMPARATIVOS. Alterações visuais transitórias são mais associadas a sildenafil, embora possam ocorrer com outros inibidores de PDE5.

C - CORRETA. Tadalafil tem meia-vida de cerca de 17,5 horas, maior que sildenafil e vardenafil (aproximadamente 3-4 horas).

D - INCORRETA (É A SOLICITADA). Mialgia e dor lombar são efeitos adversos caracteristicamente mais associados à tadalafil, não menos comuns nela.

Fontes: [8], [25].

QUESTÃO 20 | Finasterida versus dutasterida | D*

A - CORRETA. Dutasterida inibe isoenzimas 5-alfa-redutase tipo 1 e 2, e reduz DHT circulante mais intensamente que finasterida (tipo 2).

B - APROXIMADAMENTE CORRETA. Ambas reduzem volume prostático, geralmente da ordem de 18-28%; porcentagens pontuais diferem por dose, duração e estudo.

C - IMPRECISA. Disfunção erétil pode ocorrer com ambas, mas equivalência exata e incidência fixa de “8%” não podem ser universalizadas.

D - INCORRETA MAIS CLARA (É A SOLICITADA). Não há base robusta para afirmar que redução de libido é exatamente três vezes mais comum com finasterida que com dutasterida.

Ressalva / interpretação: A ausência de contexto para as porcentagens prejudica a precisão também em B e C. A distinção robusta é a inibição dual da dutasterida e os efeitos sexuais possíveis de ambas.

Fontes: [6].

QUESTÃO 21 | Alfabloqueadores utilizados na HPB: identificar a incorreta | D

A - CORRETA EM GERAL. Formulações apropriadas de tansulosina e alfuzosina são usadas uma vez ao dia; costumam apresentar menor repercussão pressórica que alguns agentes não seletivos.

B - PLAUSÍVEL. Tansulosina é amplamente utilizada, mas “a mais usada” depende do país e período e não é verdade universal.

C - CORRETA. Associação alfa-bloqueador e inibidor da 5-alfa-redutase pode ser indicada em pacientes selecionados com sintomas e próstata aumentada.

D - INCORRETA (É A SOLICITADA). Terazosina não é antagonista específico de um suposto receptor alfa-1C; é bloqueador alfa-1 não seletivo e não é comprovadamente a opção mais potente.

Fontes: [6], [22].

QUESTÃO 22 | Escroto agudo e torção testicular | B

A - INCORRETA. Ultrassonografia Doppler é útil em casos duvidosos, se obtida sem atrasar cirurgia quando a suspeita clínica é alta.

B - CORRETA. Torção deve ser excluída prontamente; a chance de salvamento é maior nas primeiras 4-6 horas, caindo com a duração da isquemia.

C - INCORRETA. É habitual realizar orquidopexia contralateral durante exploração da torção para evitar evento no lado oposto.

D - INCORRETA. Trauma contuso pode exigir cirurgia quando há rotura testicular, hematocele importante ou outras complicações.

Ressalva / interpretação: “Quase todos” preservados em até 6h é estimativa aproximada, não garantia: viabilidade depende do tempo, grau de torção e condições locais.

Fontes: [27].

QUESTÃO 23 | Hidronefrose antenatal: causas e manejo | B

A - INCORRETA. Válvula de uretra posterior pode causar obstrução grave, displasia e evolução para doença renal crônica.

B - CORRETA. Refluxo vesicoureteral nem sempre requer cirurgia; prevenção de ITU febril e dano renal, seguimento e tratamento de disfunção vesical são centrais.

C - INCORRETA. Obstrução da junção ureteropélvica pode demandar pieloplastia quando há obstrução significativa ou piora funcional.

D - INCORRETA. Injeção endoscópica de agentes de preenchimento é opção terapêutica para RVU selecionado.

Fontes: [9], [11], [28].

QUESTÃO 24 | Hipospádia: inconsistência da alternativa destacada | SEM VÁLIDA

A - REDAÇÃO CONTRADITÓRIA. Hipospádia distal/anterior constitui a maioria dos casos, porém “grande maioria ... (até 50%)” é numericamente incoerente: até 50% não define maioria.

B - INCORRETA. Hipospádias proximais/posteriores tendem a exigir reconstrução mais complexa e podem associar-se a curvatura peniana e outras alterações.

C - INCORRETA. Existem múltiplas técnicas operatórias, selecionadas pela localização do meato, curvatura e qualidade da placa uretral.

D - INCORRETA COMO NEGAÇÃO ABSOLUTA. Hipospádias proximais graves podem associar-se a dificuldades reprodutivas e ejaculatórias; não se pode descartar qualquer relação com fertilidade.

Ressalva / interpretação: O arquivo marca A. A ideia clínica da alternativa A é a pretendida, mas a expressão “até 50%” inviabiliza sua literalidade; é recomendável retificação ou anulação.

Fontes: [10], [24].

QUESTÃO 25 | Antígeno prostático específico (PSA) | D

A - INCORRETA. Prostatite, infecções e inflamação urinária/prostática podem elevar transitoriamente o PSA.

B - INCORRETA. A relação proposta em ng por grama “por ano” e multiplicador fixo de câncer não constitui regra clínica validada para diferenciar HPB de neoplasia.

C - INCORRETA. Relação PSA livre/total maior costuma reduzir, e não aumentar, a suspeita de câncer em contextos selecionados; percentuais não são diagnósticos isolados.

D - CORRETA. Inibidores da 5-alfa-redutase reduzem o PSA sérico em torno de 50% após aproximadamente 6 a 12 meses de uso.

Ressalva / interpretação: Na interpretação do PSA sob finasterida ou dutasterida, considerar duração, PSA basal, tendência e ajuste clínico (frequentemente dobrar valor medido após estabilização).

Fontes: [6], [26].

QUESTÃO 26 | Hiperplasia prostática benigna: revisão do gabarito antigo | C*

A - INCORRETA. Próstata >40 g e sintomas, por si sós, não determinam cirurgia; há opções de tratamento conservador e medicamentoso, salvo complicações e refratariedade.

B - INCORRETA. Uretrocistografia identifica alterações anatômicas, mas não é exame-padrão para comprovar obstrução prostática funcional; estudos pressão-fluxo são referência quando necessários.

C - CORRETA. Ausência de exposição androgênica puberal por castração pré-puberal impede, em regra, desenvolvimento da hiperplasia prostática dependente de andrógenos.

D - INCORRETA. “Fluxo urinário >150 mL” mistura conceitos: Qmáx é expresso em mL/s. Volume urinado superior a 150 mL é condição desejável para interpretar urofluxometria, não sinal de descompensação detrusora.

Ressalva / interpretação: CORREÇÃO DO GABARITO DO ARQUIVO: está marcada D, que é falsa. A melhor opção é C. Há provável confusão entre volume miccional, Qmáx e resíduo pós-miccional.

Fontes: [6], [7].

QUESTÃO 30 | Reconstrução urinária após cistectomia radical | D

A - INCORRETA. Neobexiga ortotópica exige critérios anatômicos, oncológicos, renais e capacidade do paciente; nem todos são candidatos.

B - INCORRETA COMO GENERALIZAÇÃO. Derivações intestinais podem gerar acidose metabólica hiperclorêmica e outras alterações metabólicas, especialmente ao longo do acompanhamento.

C - INCORRETA. Neobexiga intestinal não contrai e esvazia como bexiga com detrusor íntegro; muitos pacientes usam manobras abdominais e treinamento miccional.

D - CORRETA. Preservar, quando viável, segmento terminal do íleo reduz prejuízo da absorção de vitamina B12 e sais biliares.

Ressalva / interpretação: Mesmo com preservação do íleo terminal, há risco de deficiência de B12 após derivação intestinal; é indicado acompanhamento nutricional e metabólico prolongado.

Fontes: [13], [20], [29].

QUESTÃO 31 | Trauma renal: indicação de intervenção cirúrgica | A

A - CORRETA. Hematoma perirrenal/retroperitoneal em expansão ou pulsátil encontrado em laparotomia constitui indicação forte de exploração, especialmente com suspeita de lesão vascular.

B - INCORRETA COMO INDICAÇÃO ABSOLUTA. Lesões renais de alto grau podem receber manejo não operatório quando há estabilidade hemodinâmica e recursos apropriados.

C - INCORRETA COMO INDICAÇÃO ABSOLUTA. Extravasamento de contraste em paciente estável pode ser tratado seletivamente com angioembolização e observação, conforme cenário.

D - INCORRETA. Estadiamento incompleto requer avaliação adicional quando possível, não cirurgia obrigatória apenas por esse motivo.

Ressalva / interpretação: O contexto importa: hematoma expansivo/pulsátil durante laparotomia e instabilidade persistente são indicações relevantes; nem todo hematoma retroperitoneal deve ser aberto.

Fontes: [12].

QUESTÃO 32 | Bactérias e padrões epidemiológicos das ITUs | C

A - INCORRETA COMO PADRÃO TÍPICO. Gestantes são frequentemente acometidas por E. coli e estreptococo do grupo B; Pseudomonas e estafilococos não formam o par habitual dominante.

B - INCORRETA. Staphylococcus saprophyticus é causa reconhecida de cistite, mas cultura e identificação podem demandar condições específicas; não existe garantia geral de crescimento “rápido e diagnóstico fácil”.

C - CORRETA. Staphylococcus aureus isolado na urina pode representar semeadura hematogênica a partir de bacteremia, especialmente sem manipulação urinária; também pode ocorrer por outras vias.

D - INCORRETA COMO REGRA. Streptococcus agalactiae (grupo B) é importante em gestantes e alguns grupos vulneráveis, mas não é a causa nosocomial predominante geral.

Ressalva / interpretação: S. aureus na urocultura não comprova por si só bacteremia: investigar cenário clínico, sintomas, dispositivos e eventual indicação de hemoculturas.

Fontes: [4], [23].

QUESTÃO 33 | Fatores predisponentes a infecção urinária: enunciado ambíguo | D*

A - POTENCIALMENTE CORRETA. Incontinência na infância associada a disfunção vesicointestinal, esvaziamento incompleto ou constipação pode aumentar risco de ITU; isoladamente, o termo é pouco específico.

B - NÃO COMPROVADA COMO REGRA. Mudanças hormonais que aumentam risco são sobretudo hipoestrogenismo pós-menopausa; “alteração hormonal em mulheres jovens” é vaga.

C - NÃO É FATOR TÍPICO ISOLADO. Vida sexual pode influenciar riscos e ISTs, mas “início precoce” em homens não é fator geral estabelecido para ITU bacteriana.

D - MAIS DEFENSÁVEL NO SENTIDO DE RISCO DE INFECÇÕES POR BACTÉRIAS RESISTENTES. Uso recente de antibióticos seleciona patógenos resistentes e se associa a quadros de ITU complicada/recorrente.

Ressalva / interpretação: GABARITO ANTIGO: D. A questão é ambígua porque A também pode representar fator de risco, dependendo da causa da incontinência. Antibioticoterapia prévia é fator de risco bem estabelecido para organismos resistentes, não sinônimo de causa necessária de nova ITU.

Fontes: [4], [23].

QUESTÃO 34 | Localização habitual do adenocarcinoma de próstata | C

A - INCORRETA. Zona central é origem menos frequente de adenocarcinoma que a zona periférica.

B - INCORRETA. Região anterior pode abrigar tumores, mas não é a localização predominante.

C - CORRETA. A maioria dos adenocarcinomas prostáticos surge na zona periférica.

D - INCORRETA. Zona de transição é a região tipicamente associada ao crescimento nodular de HPB; pode ter câncer, mas não é a principal zona de origem.

Fontes: [14].

QUESTÃO 35 | Estadiamento TNM T3bN0M0 | A

A - MELHOR OPÇÃO. T3b indica invasão de vesículas seminais, N0 ausência de metástase regional e M0 ausência de metástase a distância.

B - INCORRETA. A descrição mistura doença limitada a um lado e metástases, incompatível com T3bN0M0.

C - INCORRETA. Invasão de músculos elevadores do ânus é critério de T4, não T3b, além de haver indicação errada sobre palpabilidade.

D - INCORRETA. Bilateralidade intraprostática relaciona-se a T2c, e a alternativa ainda atribui metástases ausentes em N0M0.

Ressalva / interpretação: A informação de palpabilidade no toque não é necessária para inferir toda a apresentação tumoral a partir do TNM usado no enunciado; a âncora para T3b é invasão de vesícula seminal.

Fontes: [14].

QUESTÃO 39 | Febre, disúria, dor lombar e urina com múltiplas alterações | SEM LETRA

Ressalva / interpretação: O conjunto clínico é compatível com ITU febril sistêmica/pielonefrite (gabarito antigo: “ITU alta”); nitrito positivo e leucocitúria são favoráveis. Entretanto, o exame anotado contém 500.000 hemácias, 200.000 isomórficas e 400.000 dismórficas, total 600.000: inconsistência aritmética. Dismorfismo eritrocitário importante sugere possível componente de hematúria glomerular concomitante e exige repetição do sedimento, revisão da contagem, investigação de proteinúria, função renal e avaliação específica conforme apresentação. Não há alternativas nem pergunta completa no PDF para escolher uma letra.

Fontes: [4], [19].

QUESTÃO 40 | Úlcera genital dolorosa, lesões em beijo e bubão inguinal | B*

A - INCORRETA. Corpúsculos de Donovan são achado de donovanose, caracterizada tipicamente por lesões ulceradas pouco dolorosas e sangrantes; bubão supurativo não é a apresentação clássica.

B - MAIS COMPATÍVEL ENTRE AS OPÇÕES. Cancro mole por Haemophilus ducreyi associa-se a úlcera dolorosa não endurecida e linfadenite supurativa; Gram pode mostrar bacilos/cocobacilos Gram-negativos.

C - MENOS COMPATÍVEL. Linfogranuloma venéreo por Chlamydia trachomatis pode ter bubão, mas lesão primária costuma ser pequena, transitória e pouco dolorosa.

D - INCORRETA. Diplococos Gram-negativos intracelulares sugerem Neisseria gonorrhoeae e não são o achado etiológico do cancro mole.

Ressalva / interpretação: IMPORTANTE: a bacterioscopia pelo Gram do bubão não é método confiável para confirmar H. ducreyi. Conforme CDC, confirmação depende de cultura especial ou NAAT/PCR validada onde disponível, com exclusão de sífilis e herpes; a opção B é apenas a mais próxima dentre exames insuficientes.

Fontes: [15].

Referências e fontes de conferência

Links para diretrizes, organismos oficiais e publicações. As fontes indicadas em cada questão referem-se aos tópicos respectivos e não substituem avaliação individual de pacientes. A literatura posterior a 2019 é utilizada para revisão técnica contemporânea.

[1] KDIGO (2025). Guideline on Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease.
https://kdigo.org/guidelines/autosomal-dominant-polycystic-kidney-disease-adpkd/kdigo-2025-adpkd-guideline/

[2] Pei et al. Somatic PKD2 mutations: two-hit model of ADPKD. JASN (1999).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10405208/

[3] KDIGO (2012). Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury (inclui classificação e terapia substitutiva).
https://kdigo.org/wp-content/uploads/2016/10/KDIGO-2012-AKI-Guideline-English.pdf

[4] EAU (2026). Guidelines on Urological Infections.
https://uroweb.org/guidelines/urological-infections/chapter/the-guideline

[5] EAU. Urolithiasis: Metabolic Evaluation and Recurrence Prevention.
https://uroweb.org/guidelines/urolithiasis/chapter/metabolic-evaluation-and-recurrence-prevention

[6] EAU. Non-neurogenic Male LUTS: Disease Management.
https://uroweb.org/guidelines/management-of-non-neurogenic-male-luts/chapter/disease-management

[7] EAU. Non-neurogenic Male LUTS: Diagnostic Evaluation (urofluxometria).
https://uroweb.org/guidelines/management-of-non-neurogenic-male-luts/chapter/diagnostic-evaluation

[8] EAU. Management of Erectile Dysfunction - farmacologia dos PDE5i.
https://uroweb.org/guidelines/sexual-and-reproductive-health/chapter/management-of-erectile-dysfunction

[9] EAU. Paediatric Urology - Vesicoureteric Reflux.
https://uroweb.org/guidelines/paediatric-urology/chapter/vesicoureteric-reflux

[10] EAU. Paediatric Urology - Hypospadias.
https://uroweb.org/guidelines/paediatric-urology/chapter/hypospadias

[11] EAU. Paediatric Urology - PUJ Obstruction.
https://uroweb.org/guidelines/paediatric-urology/chapter/dilatation-of-the-upper-urinary-tract-puj-obstruction

[12] EAU. Urological Trauma - indicações para exploração renal.
https://uroweb.org/guidelines/urological-trauma/chapter/urogenital-trauma-guidelines

[13] EAU. Muscle-invasive Bladder Cancer - opções e contraindicações de derivação urinária.
https://uroweb.org/guidelines/muscle-invasive-and-metastatic-bladder-cancer/chapter/disease-management

[14] EAU. Prostate Cancer - TNM Classification and Staging.
https://uroweb.org/guidelines/prostate-cancer/chapter/classification-and-staging-systems

[15] CDC. Chancroid - Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines.
https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/chancroid.htm

[16] CDC. Clinical Guidance for Post-Streptococcal Glomerulonephritis (2025).
https://www.cdc.gov/group-a-strep/hcp/clinical-guidance/post-streptococcal-glomerulonephritis.html

[17] Brazilian Dialysis Survey 2024. Brazilian Journal of Nephrology (2026).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12922704/

[18] Brazilian Dialysis Survey 2023. Brazilian Journal of Nephrology (2025).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11801593/

[19] Phase contrast microscopic examination of urinary erythrocytes. J Clin Pathol (1993).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC501394/

[20] Pannek et al. Ileal urinary diversion and vitamin B12 absorption. Journal of Urology (1996).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8632531/

[21] EAU. Kidney stone composition and metabolic risk - Urolithiasis.
https://uroweb.org/guidelines/urolithiasis/chapter/guidelines

[22] EAU. Male LUTS - alfa-antagonistas e efeitos sobre obstrução prostática.
https://uroweb.org/guidelines/management-of-non-neurogenic-male-luts/chapter/disease-management

[23] EAU. Urological Infections - fatores de risco e antibióticos prévios.
https://uroweb.org/guidelines/urological-infections/chapter/the-guideline

[24] Hypospadias Urogenital Reconstruction - StatPearls (NCBI).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK564407/

[25] EAU. Erectile Dysfunction: eventos adversos e refeições gordurosas.
https://uroweb.org/guidelines/sexual-and-reproductive-health/chapter/management-of-erectile-dysfunction

[26] EAU. Prostate Cancer - avaliação de PSA, interpretação e infecção.
https://uroweb.org/guidelines/prostatecancer/chapter/diagnostic-evaluation

[27] AUA. Testicular torsion - management and time-critical surgery (medical reference).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448199/

[28] EAU. Paediatric Urology - posterior urethral valves (VUP).
https://uroweb.org/guidelines/paediatric-urology/chapter/congenital-lower-urinary-tract-obstruction

[29] Urinary diversion and serum B12 after ileal neobladder. Urology (2000).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10925085/

[30] Cystitis pathogenesis, common urinary pathogens (EAU).
https://uroweb.org/guidelines/urological-infections/chapter/the-guideline

[31] KDIGO (2024). Clinical Practice Guideline for Chronic Kidney Disease: G/A classification.
https://kdigo.org/wp-content/uploads/2024/03/KDIGO-2024-CKD-Guideline.pdf

[32] Membranous Nephropathy: histologic findings and secondary causes (NCBI Bookshelf).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559169/

Nota de integridade documental. As sete páginas da prova recebida, inclusive os destaques amarelos e o gabarito preexistente, foram mantidas sem alterações. Este apêndice é a revisão independente e prevalece como resposta técnica recomendada quando houver divergência explicitamente justificada.